

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2
Ngày 21 tháng 4 năm 2026

Ngày 21 tháng 4 năm 2026, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì buổi họp với Ban Điều hành, các khoa của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2.

Sau khi các khoa, phòng báo cáo tiến độ thực hiện và trao đổi, thảo luận với đại diện các khoa, Ban Điều hành, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện có kết luận, chỉ đạo thực hiện các công tác sau trước ngày 28/4/2026:

1. Đối với công tác Hành chính quản trị:

a) Công tác ngoại cảnh:

- Khu nhà nhân viên: HCQT trang bị camera hướng quay ra cổng vào khu nhà nhân viên.

- Để xe đúng khu vực gửi xe: HCQT + Thanh niên xung phong rà soát không để người bệnh, người nhà, nhân viên y tế để xe máy, xe hơi không đúng vị trí quy định ở Cấp cứu, trước phòng khám, khu vực nhà ăn nhân viên, khu vực giữa khu D và khu G.

- Khu vực cấp cứu: Bảng thông tin tại phòng họp CC: KHTH + Điều Dưỡng + HCQT bảng kẹp thông tin trực của lãnh đạo, bác sĩ, điều Dưỡng, và các số đường dây nóng.

- HCQT đi rà soát các tủ inox, bồn inox đánh số, tập kết tập trung 1 vị trí và báo cáo số lượng.

- Đồng thuận với đề xuất của Điều dưỡng + HCQT + TCCB về phương án hoạt động và nhân sự của đơn vị làm sạch, với nhân sự tối thiểu là 8 nhân sự. HCQT làm tờ trình triển khai cụ thể cho TCCB và BGĐ.

2. Đối với công tác chuyên môn:

a) Công tác kiểm tra, giám sát:

- KHTH giám sát các bệnh nhân chuyển viện đã làm Bilan tầm soát.

- KHTH giám sát việc ghi nhận bệnh nền rõ ràng chi tiết, hạn chế ghi chung chung.

- Giám sát, đánh giá tổng kết bệnh án Thận nhân tạo:

+ Giám sát cá thể hóa từng người bệnh.

+ Xây kế hoạch chạy thận cá thể hóa cho từng người bệnh, điều trị toàn diện bệnh nền, bệnh lý kèm theo (Diễn tiến, theo dõi biến chứng, bilan tầm soát).

+ KHTH + Điều Dưỡng triển khai những hoạt động sau khi học tập TNT ở BV LVT, chăm sóc quản lý chuyên sâu, theo nhóm như thế nào, báo cáo cụ thể tiến độ triển khai.

- TCCB + KHTH triển khai việc giám sát tuân thủ đúng phác đồ điều trị, phác đồ khám toàn diện, từ đó đánh giá hiệu quả làm việc của bác sĩ.

- KHTH triển khai và báo cáo công tác giám sát khám toàn diện theo thời gian thực, can thiệp tức thì, và đánh giá hiệu quả của việc can thiệp.

- KHTH báo cáo, phân tích chi tiết các ca tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt.

b) Công tác khám và điều trị:

- KHTH báo cáo ngày cụ thể triển khai nội soi tiêu hóa, số lượng triển khai, cách thức thực hiện chi tiết.

- Nhà đại thể: KHTH kiểm soát kỹ các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc về nhà đại thể. KHTH báo cáo:

- + Cách thức hoạt động.

- + Luồng di chuyển.

- + Liên hệ khi có sự việc xảy ra.

- Khám toàn diện cho BN bán cấp cứu: KHTH xây dựng Bilan cho BN bán cấp cứu.

- KHTH xây dựng Bilan cho Shock nhiễm trùng, những CLS, LS phải giải quyết trong 24 giờ, chia độ shock. Phác đồ điều trị cần chi tiết (bảng kiểm, tần suất đánh giá bảng kiểm).

- Trục đêm khoa Nhi: TCCB + KHTH + Điều dưỡng điều nhân sự Khoa Sơ sinh CS1 bổ sung trục đêm khoa Nhi ở CS2.

- KHTH sắp xếp BS GMHS học tập ở Khoa Cấp cứu và Khám Nội.

- KHTH rà soát lại bảng checklist khám toàn diện đã trình, cần làm rõ việc phối hợp giữa các bộ phận, giữa các phòng khám chuyên khoa.

- KHTH xây dựng các bộ CLS thường quy theo triệu chứng, ICD bệnh. Ví dụ tim mạch ở người lớn tuổi thì ECG phải nằm trong bộ CLS thường quy bắt buộc.

- KHTH + K.Dược + YHCT triển khai thuốc thang, thuốc bóc tại bệnh viện CS2. Quy trình, vận chuyển, lưu trữ, hẹn người bệnh.

3. Đối với công tác quản lý khác:

a) Công tác truyền thông:

- Nuôi con bằng sữa loài người “Human Milk”: Điều dưỡng + CTXH thiết kế poster về nuôi con bằng sữa mẹ, có mô tả sự phát triển dạ dày của trẻ sơ sinh từ lúc mới sinh đến 1000 đầu đời tại vị trí:

- + Khoa sản: các phòng hậu sản.

- + Khoa GMHS.

- + Phòng Khám Nhi.

b) Công tác quản lý chung:

- Báo cáo các nội dung TB KL cuộc họp: KHTH, ĐD, HCQT, VTTBYT rà soát các nội dung trong TB KL cuộc họp với Giám đốc từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2026, báo cáo tổng kết các hạng mục chưa triển khai, đang thực hiện.

- Điều dưỡng + HCQT giám sát việc mặc áo đồng phục đúng quy định đối với NB (áo người bệnh) và người nhà (áo vàng) đúng quy định.

- Kho: VTTBYT + HCQT rà soát các kho máy móc TTB không nhận cần niêm phong và khóa lại (ghi ngày niêm phong và có chữ ký, không được ra vào).

- VTTBYT rà soát các TTB cho phòng mổ chuyển vào phòng mổ.

- VTTBYT + HCQT làm tờ trình triển khai di dời máy CT scan (nội dung thực hiện, ai thực hiện, thời gian thực hiện, chi phí ra sao), phương án di dời, bảo quản máy cũ tránh lãng phí tài sản công.

- KHTH làm báo cáo sau khi đưa vào sử dụng máy CT thì những ca chuyển viện nào có thể giữ lại. Cách thức đánh giá hiệu quả trong quý 2, quý 3.

- KHTH + Điều Dưỡng + CTXH trình kế hoạch làm sao để có bệnh sử dụng máy CT, kế hoạch cần tính khả thi, tính thực tế.

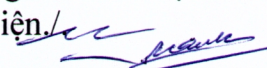
- KSNK + VTTB: đi học tập BV LVT được Nhật tài trợ xử lý đồ vải. Thực hiện báo cáo công suất xử lý đồ vải ở CS2 và khả năng nâng công suất tối đa, xử lý cho CS1.

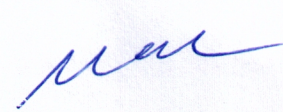
- Điều dưỡng chuẩn bị báo cáo ở CS1 về lưu đồ in toa thuốc tập trung, lưu đồ khoa Khám bệnh.

- QLCL khảo sát hài lòng người bệnh cần có kế hoạch, hình thức triển khai chi tiết và được Giám đốc duyệt mới triển khai.

- Đồng thuận chủ trương về công văn của BV Mắt về mổ đục thủy tinh thể. TCCB + KHTH + ĐD + HCQT + CTXH phối hợp triển khai chủ động với vai trò BVTD CS2 là đơn vị tổ chức thực hiện chính từ khâu tiếp nhận đến vào phòng mổ, từ phòng mổ ra đến hậu phẫu và tư vấn tái khám. HCQT lưu ý chuẩn bị tốt các khâu hậu cần, CTXH chuẩn bị tốt khâu truyền thông, quảng bá.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp thông báo Kết luận của Giám đốc để các khoa, phòng liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện.


GIÁM ĐỐC


BS. CKII. Trần Ngọc Hải